

3541 พงษ์

แนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (Perioperative Nursing Care)

4 พงษ์

1-5 พงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจน์นิชา เรืองชัยทวิสุข
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์: นิสิตสามารถ

1. อธิบายวัตถุประสงค์ และประเภทของการผ่าตัดได้
2. อธิบายการตอบสนองทางด้านร่างกายต่อการผ่าตัดได้
3. อธิบายระยะของการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดได้
4. อธิบายการพยาบาลผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัดได้
5. อธิบายการพยาบาลผู้ป่วยในระยะขณะผ่าตัดได้
6. อธิบายการพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดทันทีที่ห้องผ่าตัดและในระยะต่อมาที่หอผู้ป่วยได้

ระยะขณะผ่าตัด

ปัญหาและการพยาบาล

ทีมผ่าตัด

ทีมผ่าตัด ประกอบด้วย



แพทย์ผ่าตัด/ผู้ช่วย
ผ่าตัด



วิสัญญีแพทย์/วิสัญญี
พยาบาล



- Scrub nurse
- Circulating nurse
- คนงาน
- เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ประจำห้อง
ผ่าตัด

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในห้องผ่าตัด

: พยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัด (Scrub nurse)

- 1) เตรียมเครื่องมือผ่าตัด อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผ่าตัดแต่ละรายให้พร้อมใช้งาน
- 2) ช่วยศัลยแพทย์และผู้ช่วยศัลยแพทย์ขณะทำการผ่าตัด
- 3) สอนและให้คำแนะนำบุคลากรใหม่ที่มาฝึกงาน
- 4) รับผิดชอบร่วมกับพยาบาลช่วยรอบนอกในการตรวจนับเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการผ่าตัด พร้อมทั้งแจ้งการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- 5) มีความชำนาญในการใช้และส่งเครื่องมือผ่าตัด คล่องแคล่ว ว่องไว มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
- 6) ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการของเทคนิคปลอดเชื้ออย่างเคร่งครัด

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในห้องผ่าตัด

: พยาบาลช่วยรอบนอก (Circulating nurse)

- 1) ช่วยเหลือทีมผ่าตัดปลอดเชื้อ โดยรับผิดชอบในการบริหารจัดการการทำงานของพยาบาลส่งเครื่องมือ และบุคลากรอื่น ๆ ในห้องผ่าตัด
- 2) ประเมินผู้ป่วย และวางแผนให้การพยาบาลผู้ป่วยแต่ละราย ตามความต้องการของผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
- 3) ดูแล รักษาและระมัดระวังการปนเปื้อนเชื้อ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ และคงไว้ซึ่งมาตรการในการควบคุมกสนปลอดเชื้อ
- 4) ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกหรือมีส่วนร่วมในการผ่าตัดตามที่ต้องการ
- 5) ตรวจสอบความปลอดภัย และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำผ่าตัด ดูแลรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในห้องผ่าตัด : วิสัญญีพยาบาล (Anesthetic nurse)

- 1) เยี่ยมและประเมินสภาพผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่หอผู้ป่วยก่อนวันผ่าตัด
- 2) ให้คำแนะนำในเรื่องการปฏิบัติตัวก่อนระงับความรู้สึกและหลังระงับความรู้สึก รวมทั้งสิ่งที่ผู้ป่วยจะต้องพบในห้องผ่าตัด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและสร้างความร่วมมือในการระงับความรู้สึก
- 3) จัดเตรียมอุปกรณ์ในการระงับความรู้สึก ให้พร้อมใช้งาน
- 4) จัดเตรียมและตรวจสอบเครื่องระงับความรู้สึก (Anesthetic machine)
- 5) จัดเตรียมยาที่ใช้ก่อนระงับความรู้สึก ยาระงับความรู้สึก IV fluid ชนิดต่าง ๆ ยาฉุกเฉิน และยาที่ใช้ในการ reverse ผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้น

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในห้องผ่าตัด : วิสัญญีพยาบาล (Anesthetic nurse) (ต่อ)

- 6) ตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เช่น การงดน้ำงดอาหาร การเตรียมผิวหนังบริเวณผ่าตัด การถอดฟันปลอม เครื่องประดับ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผล X-Rays การเตรียมเลือด ให้ถูกต้องหรือพร้อมใช้งาน
- 7) ช่วยจัดท่าผู้ป่วยเพื่อเตรียมระงับความรู้สึก ตรวจวัดสัญญาณชีพและติด monitor ต่าง ๆ ให้พร้อม และคอยช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับวิสัญญีแพทย์
- 8) ช่วยศัลยแพทย์และพยาบาลในการจัดทำผ่าตัด โดยระมัดระวังมิให้รบกวนหรือเกิดอันตรายต่อการระงับความรู้สึกของผู้ป่วย

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในห้องผ่าตัด : วิสัญญีพยาบาล (Anesthetic nurse) (ต่อ)

- 9) สังเกตอาการผู้ป่วยขณะผ่าตัดเป็นระยะ ๆ อย่างใกล้ชิด และบันทึกในรายงานการระงับความรู้สึก หากพบสิ่งผิดปกติต้องรีบรายงานวิสัญญีแพทย์ ศัลยแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ และรีบให้การดูแล แก้ไขผู้ป่วยทันที
- 10) ภายหลังผ่าตัด ต้องให้การช่วยเหลือผู้ป่วยให้ฟื้นกลับคืนสู่ปกติ และดูแลส่งผู้ป่วยไปยังห้องพักรักษาตัว เพื่อให้การดูแลต่อไปจนกว่าจะมีสัญญาณชีพปกติ ระดับความรู้สึกดี และไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ จึงจะส่งกลับหอผู้ป่วยได้ หากผู้ป่วยมีอาการไม่ดีจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด อาจต้องส่งผู้ป่วยไปดูแลต่อที่ ICU



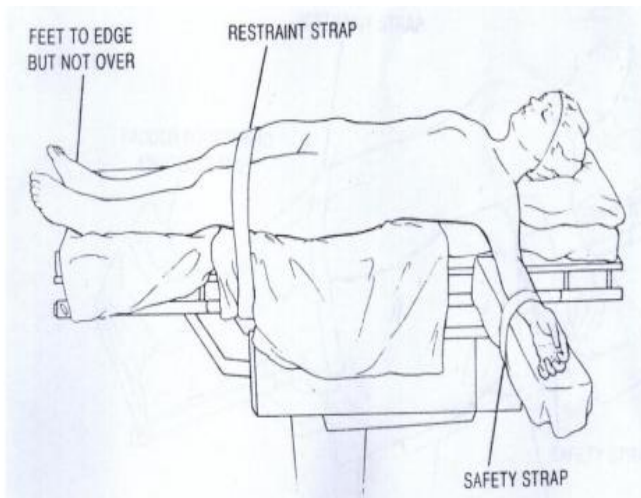
การจัดท่าผู้ป่วยสำหรับการผ่าตัด

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้แพทย์ผู้ผ่าตัดมองเห็นบริเวณที่จะทำผ่าตัดได้ชัดเจน สามารถทำการผ่าตัดได้สะดวก
วิสัญญีแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตลอดเวลาของการผ่าตัด

สิ่งที่ต้องคำนึง:

ถูกต้องตามลักษณะกายวิภาคของร่างกาย (Body alignment)
ผู้ป่วยสุขสบาย
ปลอดภัยมากที่สุดตลอดระยะเวลาของการผ่าตัด



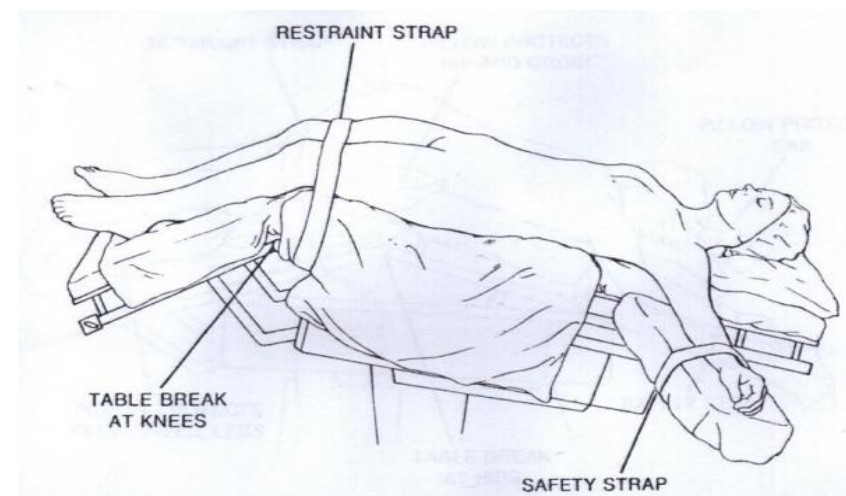
Supine position



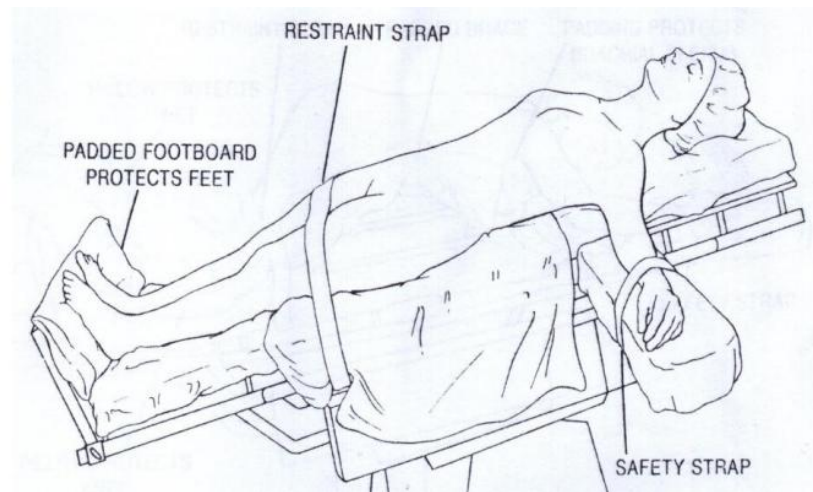
The neck hyperextended



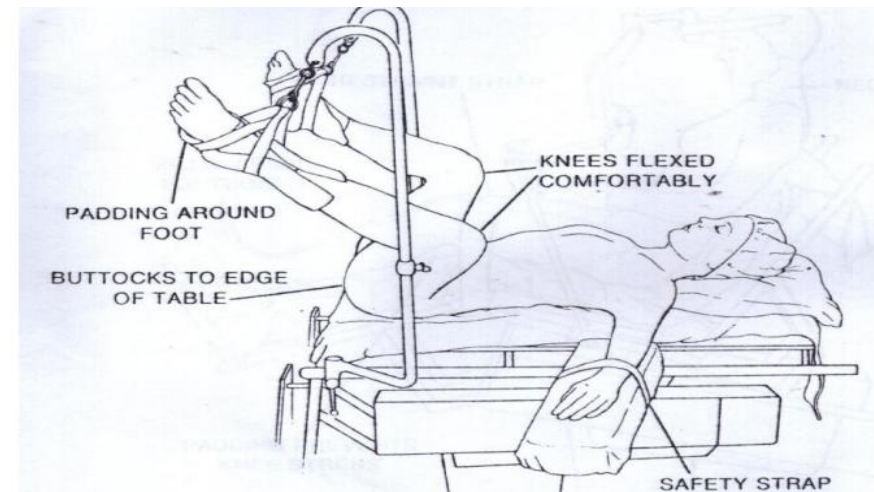
การจัดท่าสำหรับผ่าตัด M.R.M



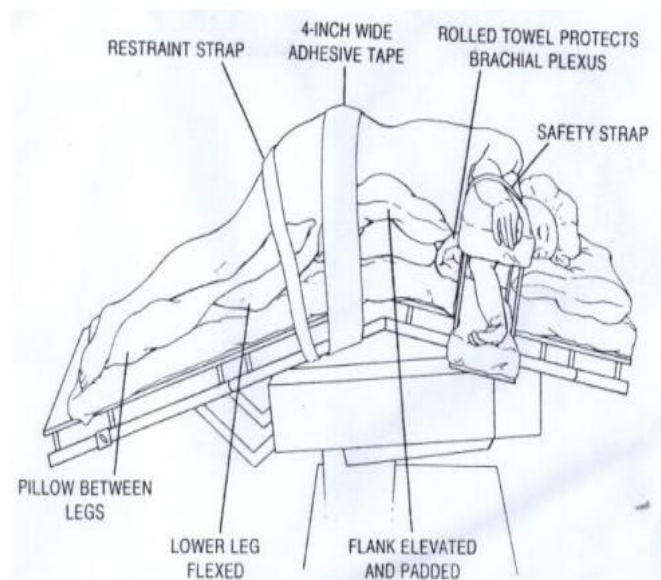
Trendelenburg position



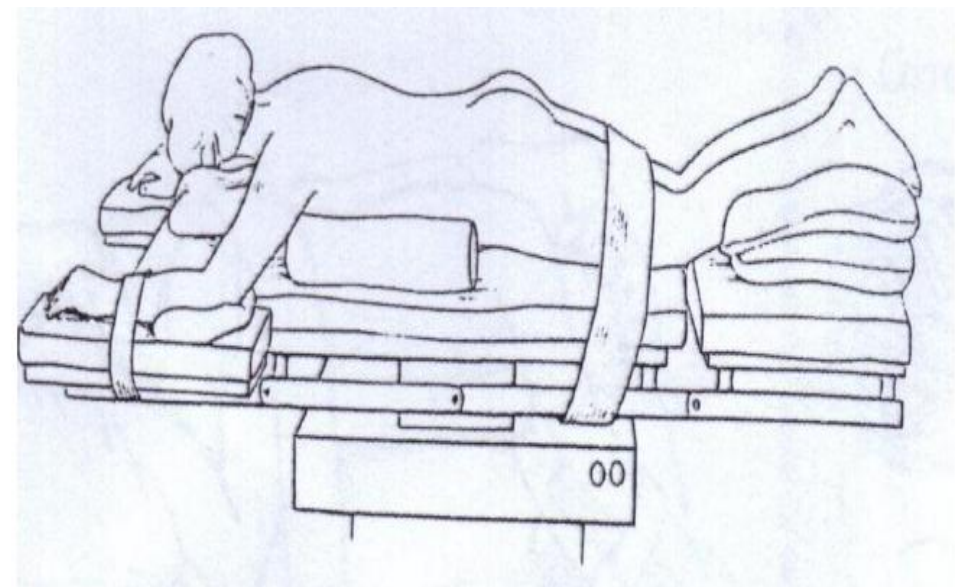
Trendelenburg position



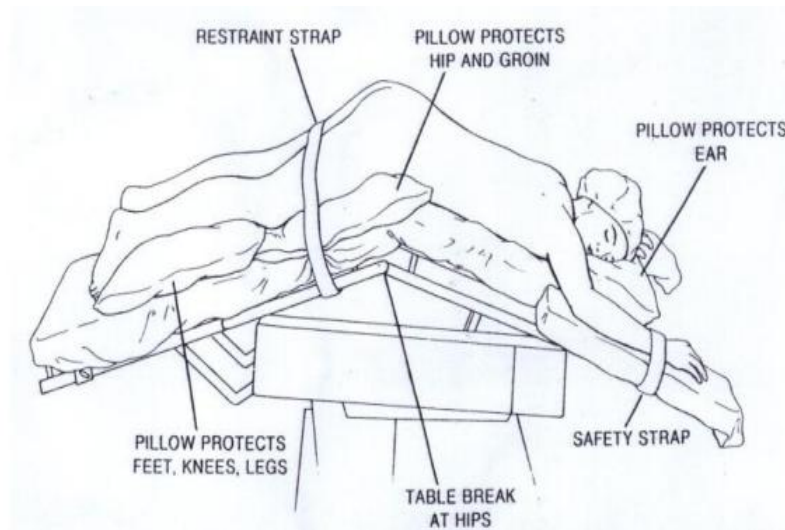
Lithotomy position



Lateral position



Prone position



Jackknife position

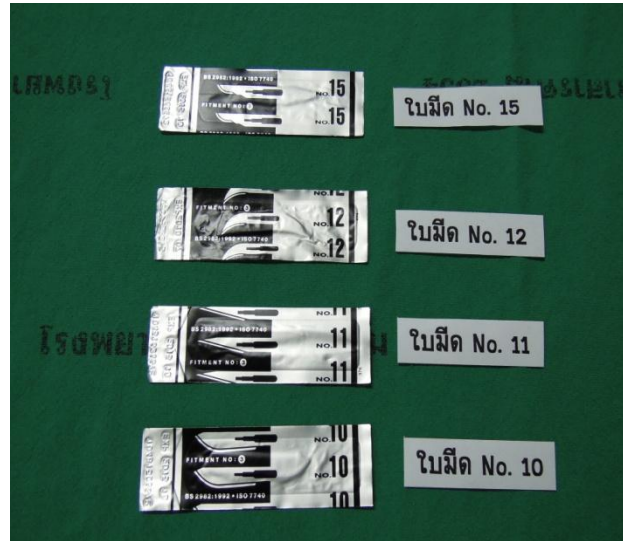


Fracture table position

ขั้นตอนการปูผ้าคลุมผ่าตัด



เครื่องมือผ่าตัด



การส่งเครื่องมือผ่าตัด



การจัดเรียงเครื่องมือที่จะทำผ่าตัด (Table Set up)

อุปกรณ์

1. รถ Mayo stand

2. ปลอก Mayo stand

3. ผ้า Towel sheet ปูคลุมทับปลอก Mayo

การจัดเรียงเครื่องมือบน Mayo Stand

เรียงตามลำดับการใช้งานก่อนหลัง พร้อมใช้งาน

ขึ้น Mayo stand เฉพาะเครื่องมือที่จะเป็นจะต้องใช้

การตรวจนับเครื่องมือและผ้าซับเลือด



วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันเครื่องมือหรือผ้าซับเลือด
ตกค้างอยู่ในบริเวณผ่าตัด ซึ่งก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ป่วย ได้



ขั้นตอนในการนับ

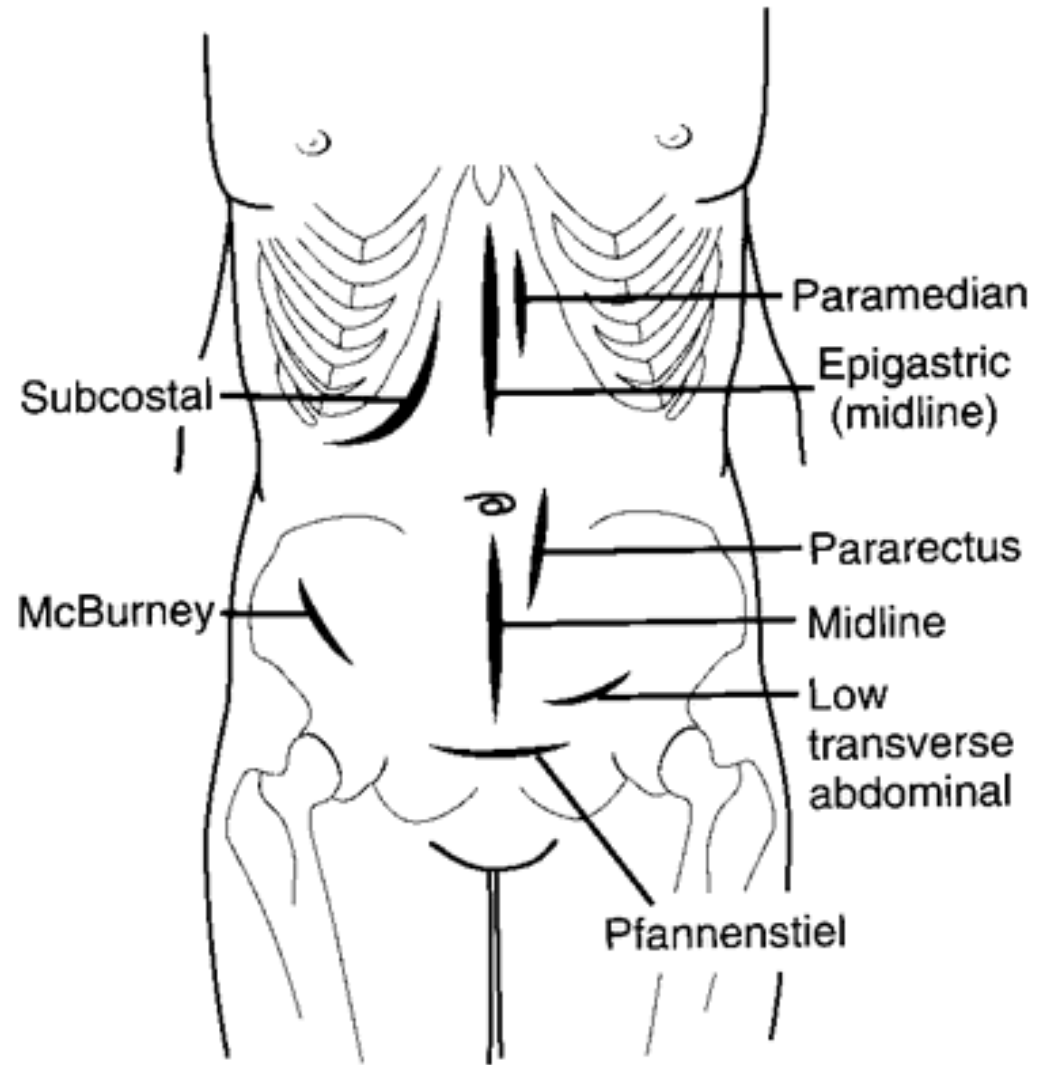
1. ผู้ที่บรรจุหรือห่อผ้าซับเลือด เพื่อส่งสิ่งที่แผนก supply จะต้อง
ตรวจนับก่อนบรรจุส่ง และเซ็นชื่อกำกับวันที่บรรจุ

2. Scrub nurse จะนับผ้าซับเลือดที่ละผืนร่วมกับ circulating nurse
และจดบันทึกไว้บนกระดานในห้องผ่าตัด ก่อนเริ่มผ่าตัด

3. ก่อนที่ศัลยแพทย์จะเย็บปิดชั้นในสุด Scrub nurse และ circulating
nurse จะนับผ้าซับเลือดและเครื่องมือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

4. เมื่อเสร็จสิ้นการผ่าตัด ตรวจนับเครื่องมือผ่าตัดอีกครั้งก่อนเก็บ
เครื่องมือส่งล้าง และทำความสะอาดและทำให้ปลอดเชื้อ เพื่อ
ป้องกันเครื่องมือหาย

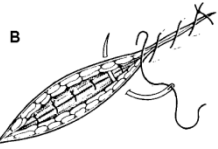
รอยแผลผ่าตัด



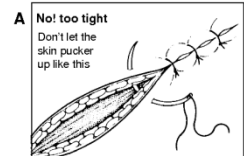
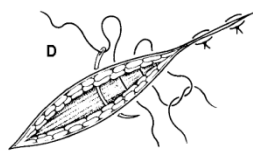
ชนิดของการเย็บแผล

SOME MORE
SUTURE METHODS – ONE

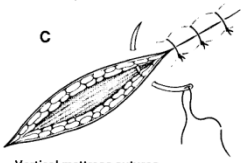
Continous sutures



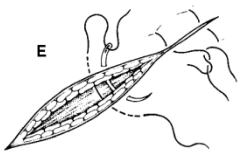
Horizontal mattress sutures



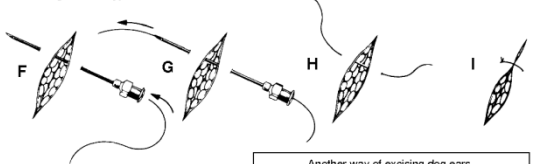
Interrupted sutures



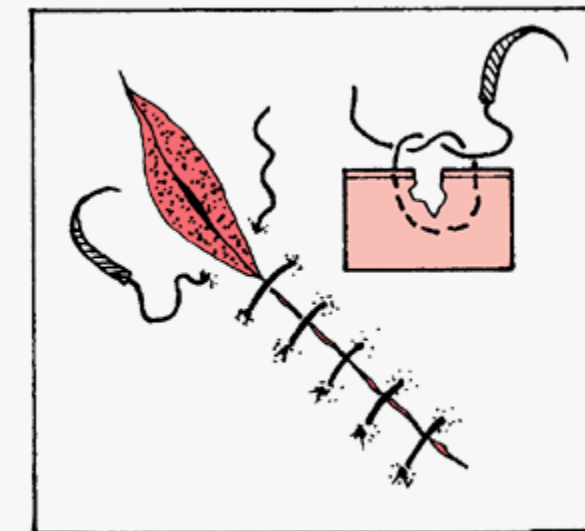
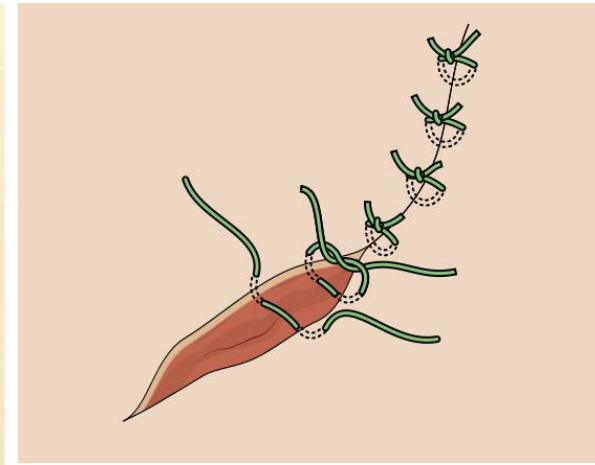
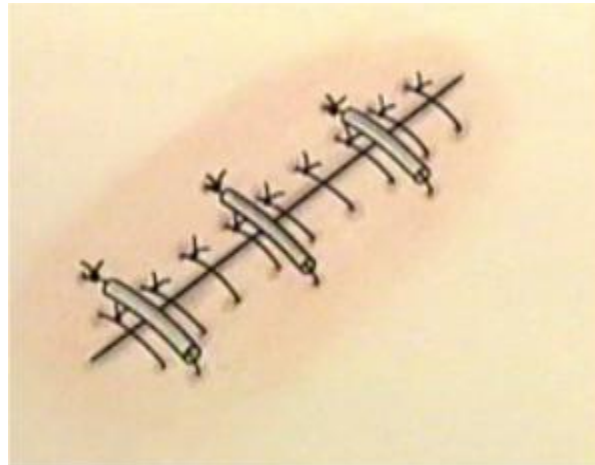
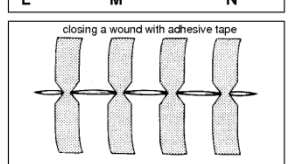
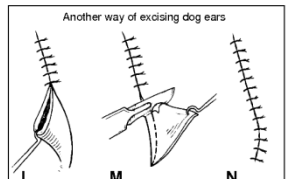
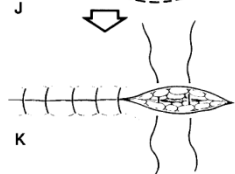
Vertical mattress sutures



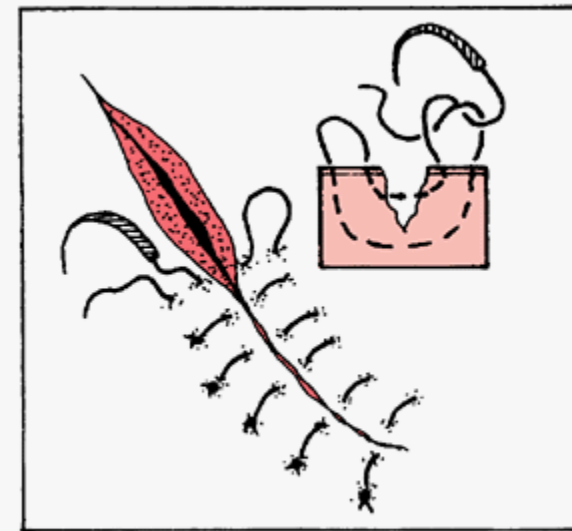
Suturing with a hypodermic needle



Excising dog ears
if the wound comes to look like
this as you stitch, cut along the
dotted line and excise a
little more skin

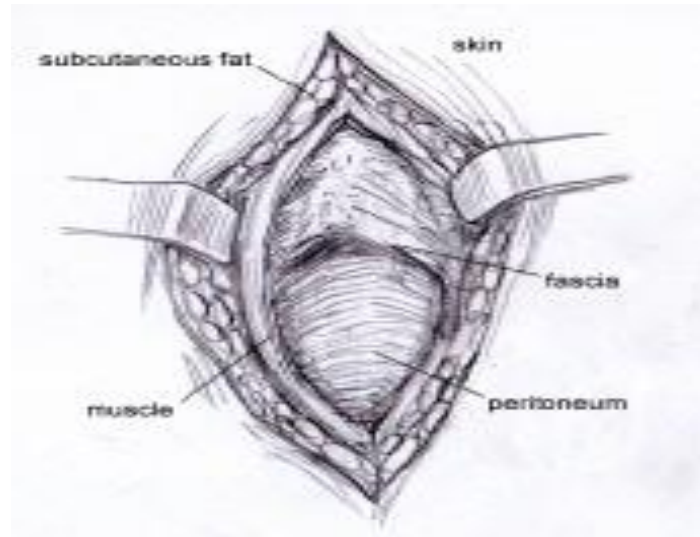
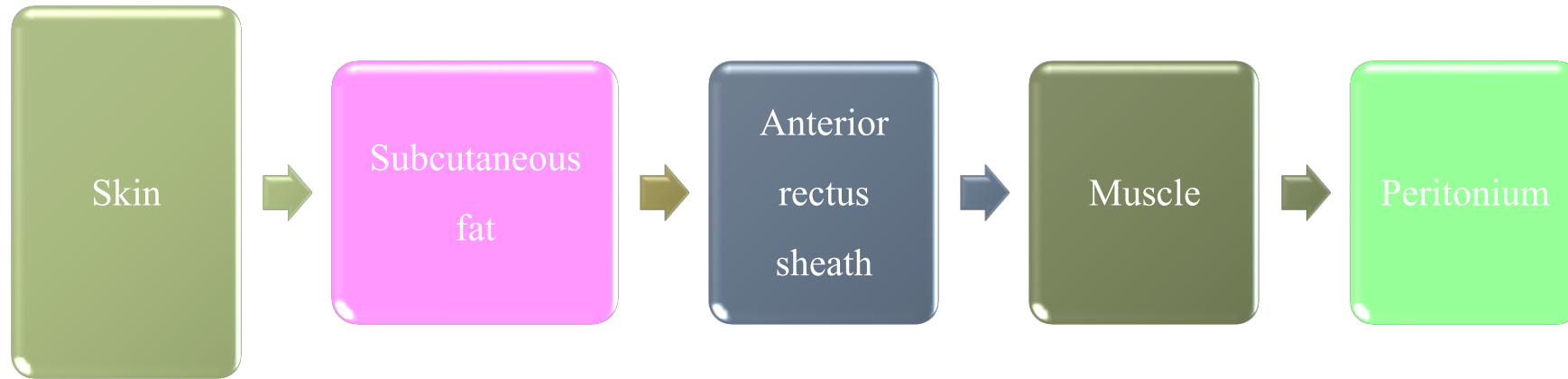


A



B

แผลผ่าตัดหน้าท้อง



ประเภทของวัสดุผูกเย็บ

- วัสดุที่สามารถละลายและถูกดูดซึมได้
(Absorbable Suture)

- วัสดุที่ไม่สามารถละลายและไม่ถูกดูดซึม
(Non – absorbable Suture)

Absorbable Suture

วัสดุที่มาจากสิ่งมีชีวิต

- Cat gut
- Plain Cat gut
- Chromic catgut

วัสดุที่ใช้มาจากการสังเคราะห์

- **Dexon**
- **Vicryl**
- **PDS**

Absorbable Suture (ต่อ)



Absorbable Suture (ต่อ)



Non – absorbable Suture

วัสดุที่ได้จากธรรมชาติ

- จากสัตว์ ได้แก่ ไหม (Silk)
- จากพืช ได้แก่ Cotton Linen
- โลหะ (Metal) ได้แก่ Tantalum, Silver, Stainless Steel และ Vitalium

วัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์

- Nylon เช่น Ethilon, Dermalon, Dafilon
- Prolene ซึ่งเป็นสารประเภท Polypropylene

Non – absorbable Suture (ต่อ)



ขนาดของเส้นวัสดุเย็บแผล

- ❑ มีหลายชนิดตั้งแต่เส้นขนาดใหญ่ที่มีความเหนียวและแข็งแรงมากไปจนถึงเส้นเล็ก ๆ เพื่อให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของเนื้อเยื่อที่เย็บ
- ❑ ขนาดของเส้นวัสดุ จะใช้แทนด้วยตัวเลข ขนาดใหญ่สุดจะเป็น No 5 แล้วค่อย ๆ เล็กลงถึง No.1 ขนาดที่เล็กลงอีก จะเริ่มจาก No.0 ส่วน 00, 000 จะเล็กลงเรื่อย ๆ เพื่อสะดวกจึงนิยมใช้ 2/0 , 3/0 จนถึง 10/0

ขนาดของเส้นวัสดุเย็บแผล (ต่อ)



ชนิดและขนาดของเข็ม

外科強弯弾 (並) General Surgical		Cutting edge 1/2 circle (H)
 角 針 SE-MH or NE-MH	直径 (柄部) Barrel φ 0.53mm	全長 Length 15mm
	0	18
	0.58	21
	0.68	24
	0.78	28
	0.78	32
	0.88	36
	0.98	41
	1.08	45
	1.08	50
	1.08	55
	1.18	60
	1.18	65
	1.28	70
	13	
		 バネ孔 SE  ナミ孔 NE
外科弱弯弾 (並) General Surgical		Cutting edge 3/8 circle (H)
 角 針 SE-ME or NE-ME	直径 (柄部) Barrel φ 0.58mm	全長 Length 18mm
	2-0	21
	0.68	24
	0.68	28
	0.78	32
	0.78	36
	0.88	41
	0.98	45
	1.08	50
	1.08	55
	1.18	60
	1.18	65
	1.28	70
	11	
		 バネ孔 SE  ナミ孔 NE

กาทาแผล

- ❖ ภายหลังที่เย็บได้ผิวหนังให้มาเกือบชิดกัน
- ❖ ดึงให้ขอบแผลทั้ง 2 ข้างมาชิดกัน
- ❖ ใช้กาทาแผลยึดให้ขอบแผลทั้งข้างแนบสนิทติดกัน
- ❖ ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย
- ❖ มีความเหนียวคล้ายกับกาตราข้าง
- ❖ ไม่ต้องตัดไหม ไม่ต้องติดพลาสติกหรือผ้าปิด แผล แก้ปัญหาการแพ้พลาสติก

กาวยาแผล



ยาที่เกี่ยวข้องกับการได้ระงับความรู้สึกขณะผ่าตัด

ยานำสลบ

ยาที่บริหารทางหลอดเลือดดำ (Intravenous anesthetics) : ออกฤทธิ์ในระยะเวลาที่เลือดออกเดินทางจากแขนถึงสมอง อาจทำให้เกิดการหยุดหายใจ ความดันโลหิตต่ำ ต้องมีอุปกรณ์ฟื้นคืนชีพด้วย ตัวอย่างยา

- ❖ *Propofol* เป็นยากล่อมประสาท อาจใช้ในระหว่างทำหัตถการสั้น ๆ
- ❖ *Thiopental* เป็นยากลุ่ม barbiturate (ใช้ระงับความรู้สึกระยะสั้น สามารถฟื้นได้ค่อนข้างเร็ว ยาจะกระจายตัวไปอยู่บริเวณที่มีหลอดเลือดมาก และเข้าไปสะสมในไขมัน ดังนั้นอาจทำให้เกิดการร่งวงซึมได้ถึง 24 ชั่วโมง)
- ❖ *Ketamine hydrochloride* สามารถระงับปวดจากการทำหัตถการสั้น ๆ หรือที่ต้องทำซ้ำ ข้อเสียคือ ทำให้เกิดอาการทางจิต เช่น ประสาทหลอน

ยาที่เกี่ยวข้องกับการได้ระงับความรู้สึกขณะผ่าตัด

ยานำสลบ

ยาสลบสูดดมชนิดไอรระเหย (Inhalational anesthetics) : ตัวอย่างยา

- ❖ **Sevoflurane** ไม่ติดไฟ มีกลิ่นฉุนแต่ไม่มาก ไม่ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ สามารถนำสลบได้เร็วทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การใช้จะนำสลบร่วมกับการให้ออกซิเจน โดยสูดดมผ่านหน้ากาก หลังจากผู้ป่วยหลับการรักษาระดับความรู้สึกแพทย์จะปรับระดับความเข้มข้นของยา ห้ามใช้ในกรณี ภาวะพร่องน้ำหรือเลือดอย่างรุนแรง (severe hypovolemia), ยาอาจทำให้ BP drop
- ❖ **Desflurane** ไม่ติดไฟ เป็นยาสลบชนิด สูดดมแบบไอรระเหยที่ละลายในเลือดได้น้อย มีกลิ่นฉุน และระคายเคืองต่อ ทางเดินหายใจ หลังจากผู้ป่วยหลับการรักษาระดับความรู้สึกแพทย์จะปรับระดับความเข้มข้นของยา ห้ามใช้ในกรณี ภาวะพร่องน้ำหรือเลือดอย่างรุนแรง (severe hypovolemia), ยาสามารถกดการหายใจได้ถ้าให้ความเข้มข้นสูง ๆ
- ❖ **Isoflurane** เป็นของเหลวใส ไม่ติดไฟ แต่มีกลิ่นฉุน ห้ามใช้ในกรณี ภาวะพร่องน้ำหรือเลือดอย่างรุนแรง (severe hypovolemia)

ยาที่เกี่ยวข้องกับการได้ระงับความรู้สึกขณะผ่าตัด

ยาหย่อนกล้ามเนื้อ

วัตถุประสงค์ของการให้ยาหย่อนกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อหย่อนตัวขณะใส่ท่อช่วยหายใจ สำหรับประกอบกรให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไป สำหรับใช้เครื่องช่วยหายใจ ยกตัวอย่างยา

- ❖ Atracurium: side effect hypotension, tachycardia, bronchospasm
- ❖ Cisatracurium: side effect คล้าย Atracurium แต่พบน้อย
- ❖ Pancuronium: side effect Hypertension, tachycardia
- ❖ Rocuronium: ระงับการใช้ในผู้ป่วยโรคตับและไต
- ❖ Succinylcholine: side effect Hyperkalemia, Hypertension, tachycardia, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการหดตัวไม่พร้อมกัน

ยาที่เกี่ยวข้องกับการได้ระงับความรู้สึกขณะผ่าตัด

ยาสงบและระงับปวด

ยาระงับปวดชนิดอนุพันธ์ฝิ่น (Opioids): ใช้ระงับปวดได้ดีมาก แต่ กดการหายใจ เกิดการติดยา พฤติกรรม เปลี่ยนแปลง ประสาทหลอน กล้ามเนื้อเกร็งตัวได้

ตัวอย่างยา Morphine sulfate, Pethidine hydrochloride, Fentanyl

ยาสงบประสาทชนิด benzodiazepine: ออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาท ช่วยให้เซลล์ไม่ไวต่อการกระตุ้นและมีความคงตัวมากขึ้น ผลทำให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวล คลายกล้ามเนื้อ และมีฤทธิ์ระงับชัก

ตัวอย่างยา Diazepam, Midazolam (มีความเสี่ยงต่อ ภาวะขาดออกซิเจน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง)

เผยประสบการณ์สยอง “ตื่นขณะผ่าตัด” พบได้ 1 ใน 19,000 คน

13 กุมภาพันธ์ 2017



สาหัส โดยไม่สามารถล้มดาหรือขยับร่างกายได้ แพทย์ชี้พบได้น้อยเพียง 1 ใน 19,000 ราย

นางดอนนา เพนเนอร์ หญิงชาวแคนาดารวัย 53 ปี เผยถึงประสบการณ์อันน่าหวาดกลัวเมื่อเธอตื่นขึ้นในระหว่างการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยโรคในช่องท้องเมื่อ 9 ปีก่อน ซึ่งอาการที่ยาสลบหมดฤทธิ์จนคนไข้ผ่าตัดรู้สึกตัวตื่นขึ้น แต่กลับไม่สามารถขยับเขยื้อนได้นี้ ทำให้เธอเจ็บปวดทรมานอย่างยิ่งตลอดการผ่าตัดที่ยาวนานกว่าหนึ่งชั่วโมง และเกิดบาดแผลทางใจที่ต้องรับการบำบัดจากจิตแพทย์ต่อมาเป็นเวลานานหลายปี

เมื่อปี 2008 นางเพนเนอร์เข้ารับการผ่าตัดส่องกล้องตรวจช่องท้องที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งของรัฐแมนิโทบาในแคนาดา เพื่อหาสาเหตุของอาการเลือดออกมากผิดปกติขณะที่มีประจำเดือน โดยแพทย์จะผ่าบริเวณท้องให้เป็นแผลเล็ก ๆ 3-4 แผลเพื่อสอดกล้องเข้าไป แทนที่จะผ่าเปิดช่องท้องเป็นแผลใหญ่แผลเดียวตามปกติ

วิสัญญีแพทย์ได้ให้เธอดมยาสลบตามปกติ แต่ในเวลาไม่นาน นางเพนเนอร์กลับรู้สึกตัวตื่นขึ้นในตอนแรกเธอดีใจและโล่งใจอย่างมากเพราะนึกว่าการผ่าตัดเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยเธอได้ยินเสียงของแพทย์พยาบาลและความเคลื่อนไหวรอบตัวชัดเจน แต่ยังไม่สามารถล้มดาขึ้นหรือขยับเขยื้อนร่างกายได้

นางเพนเนอร์ไดยินเสียงคล้ายแพทย์พูดขอมัดผ้าตัด ซึ่งทำให้เธอตื่นตระหนกสุดขีด เธออยากลุกขึ้นนั่งและขยับตัวสื่อสารเพื่อให้แพทย์ทราบว่าเธอยังตื่นอยู่ แต่ไม่สามารถทำได้เพราะยาคลายกล้ามเนื้อที่ใช้ระหว่างการผ่าตัดทำให้เธอเหมือนเป็นอัมพาตไปทั้งร่าง นางเพนเนอร์รู้สึกถึงคมมีดที่กดลงบนท้องซึ่งทำให้เจ็บปวดอย่างสุดบรรยาย แต่จำต้องทนโดยแม้แต่จะร้องให้ออกมาก็ยังทำไม่ได้

ขณะนั้นชีพจรของนางเพนเนอร์เต้นเร็วขึ้นจนถึงระดับ 148 ครั้งต่อนาที แต่ไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกตินี้ จนในที่สุดเธอพยายามกระดิกนิ้วเท้าเพื่อส่งสัญญาณได้ถึงสามครั้ง แต่พยาบาลกลับกดเท้าของเธอเอาไว้ให้หนึ่ง โดยไม่เอ่ยปากบอกแพทย์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ที่แย่ไปกว่านั้นคือเธอเริ่มหายใจไม่ออกและรู้สึกวุ่นวายเหมือนไฟเผา เพราะเครื่องช่วยหายใจถูกปรับไว้ให้หายใจเข้าได้เพียง 7 ครั้งต่อนาที ทั้งที่เธออยู่ในภาวะตระหนกและหัวใจเต้นแรง



วิสัย....pdf ^ | บทความวิชาการ-การ....pdf ^



คนไข้ที่ตื่นระหว่างผ่าตัดจะได้ยินเสียงรอบตัวและมีความรู้สึกสัมผัสชัดเจน แต่ไม่สามารถลืมตาหรือขยับร่างกายได้

เมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้นลง นางเพนเนอร์พยายามใช้ลิ้นขยับท่อยช่วยหายใจเพื่อส่งสัญญาณให้แพทย์ทราบ แต่วิสัญญีแพทย์กลับนำท่อยช่วยหายใจออกเร็วเกินไป ทำให้เธอหายใจไม่ได้และหมดสติ ซึ่งในตอนนี้นางเพนเนอร์เชื่อว่าได้สัมผัสกับประสบการณ์เฉียดความตายที่คล้ายกับวิญญาณได้ออกจากร่างไปยังสถานที่ที่สุขสงบและไม่เจ็บปวด แต่ต่อมาไม่นานเธอได้กลับฟื้นขึ้นเนื่องจากแพทย์ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจกับเธออีกครั้ง

เมื่อนางเพนเนอร์เริ่มฟื้นตัวและพูดได้ เธอได้เผยกับแพทย์ผู้รักษาถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งแพทย์ยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการผ่าตัดจริง และได้กล่าวขออภัยต่อเธอ รวมทั้งยอมรับว่าคำพูดของแพทย์ที่นางเพนเนอร์ได้ยินขณะฟื้นขึ้นระหว่างการผ่าตัดนั้น แพทย์ได้กล่าวไปอย่างที่เธอบอกจริงทั้งหมด รวมทั้งผลการวินิจฉัยโรคที่เธอไม่ได้สอบถามจากแพทย์ เพราะได้ทราบด้วยตนเองตั้งแต่อยู่ในห้องผ่าตัดแล้ว

นางเพนเนอร์ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากโรงพยาบาล เนื่องจากความกระหืดกระเทือนทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้น ซึ่งต่อมาคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงชดเชยและยอมความกันได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม เธอต้องการเผยแพร่เรื่องนี้ให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์ต่อคนไข้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดในอนาคต

ข้อมูลจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งสหราชอาณาจักรระบุว่า กรณีคนไข้รู้สึกตัวตื่นขึ้นขณะผ่าตัดนี้พบได้ราว 1 ใน 19,000 ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผ่าตัดทำคลอดทางหน้าท้อง ศัลยกรรมทรวงอก (Cardiothoracic surgery) และในคนไข้ที่อ้วนมาก แต่ส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะตื่นขึ้นเป็นเวลาสั้น ๆ เพียงไม่เกิน 5 นาทีเท่านั้น แต่ก็มีหลายรายที่ตื่นขึ้นเป็นเวลานานและรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดอย่างสาหัสจากการผ่าตัด ซึ่งร้อยละ 40 ของคนไข้กลุ่มนี้ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจในระดับปานกลางถึงรุนแรงหลังเผชิญกับประสบการณ์ดังกล่าว

ที่มา <https://www.bbc.com/thai/international-38954256>

ปัญหาของผู้ป่วยในขณะผ่าตัด

❖ การเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในระหว่างการผ่าตัด

- การตกเตียง การกดทับจากการจัดท่า อันตรายจากการใช้เครื่องมือผ่าตัด สิ่งตกค้างในแผลผ่าตัด ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ

❖ อันตรายจากการสูญเสียเลือด

❖ การติดเชื้อขณะผ่าตัด

การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะขณะผ่าตัด : การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในระหว่างผ่าตัด

อุบัติเหตุและอันตรายจาก: ตกเตียง จัดท่า ของมีคม สิ่งตกค้างในแผล และอุณหภูมิ

การพยาบาล

1. ใช้เครื่องผูกยึดลำตัว แขน ขา และไม่ให้ผู้ป่วยไ้ตามลำพัง
2. ใช้หมอนและอุปกรณ์รองรับปุ่มกระดูก และข้อต่อของร่างกายอย่างเหมาะสม: ป้องกันแผลกดทับ
3. โดยตรวจนับเครื่องมือ เครื่องใช้และผ้าซับเลือด เมื่อเริ่มและสิ้นสุดการผ่าตัดทุกครั้ง หรือตามขั้นตอนการตรวจนับ : ป้องกันสิ่งตกค้างในแผลผ่าตัด
4. ไม่เปิดเผยร่างกายผู้ป่วยโดยไม่จำเป็น หรือต้องมีการปรับอุณหภูมิภายในห้องผ่าตัดให้เหมาะสม ใช้น้ำเกลือล้างท้องต้องให้น้ำเกลือมีอุณหภูมิเท่ากับหรือสูงกว่าร่างกาย : ป้องกันภาวะ Hypothermia

การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะขณะผ่าตัด

: การป้องกันอันตรายจากการเสียเลือดในระหว่างผ่าตัด

การพยาบาล

1. ประเมินและบันทึกการสูญเสียเลือดจากขวดดูดสุญญากาศ ผ้าซับเลือด
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือหรือยาที่ช่วยในการห้ามเลือดให้พร้อมใช้งานทันที
3. จัดเตรียมเลือดและสารน้ำ เพื่อให้ทดแทนเลือดที่สูญเสียทันทีและอย่างครบถ้วน

การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะขณะผ่าตัด

: การป้องกันการติดเชื้อขณะผ่าตัด

การพยาบาล

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องผ่าตัดและเทคนิคปลอดเชื้ออย่างเคร่งครัด
2. การเตรียมความสะอาดเฉพาะที่ การฟอกผิวหนังและยาระงับเชื้ออย่างถูกต้องตามเทคนิค
3. มาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในห้อง โดยหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหว พูดคุย และเดินเข้าออกห้องผ่าตัดโดยไม่จำเป็น
4. ป้องกันการปนเปื้อนของเครื่องมือ เครื่องใช้ ขณะผ่าตัดควรแยกออกจากเครื่องมือที่ปลอดเชื้อ หรือเอาออกนอกโต๊ะส่งเครื่องมือ
5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของร่างกายและตกแต่งบาดแผลให้เหมาะสมกับการผ่าตัด

ขอบคุณจ้า

